Spironolaktón a finerenón pri chronickej chorobe obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.11.2026



Ilustrácia vytvorená pomocou umelej inteligencie. Tablety neznázorňujú konkrétne lieky.

Spironolaktón v dávke 25 mg a finerenón v dávke 20 mg dosiahli v sieťovej metaanalýze podobný pokles albuminúrie. Tento výsledok vychádza prevažne z nepriamych porovnaní. Pre rozhodovanie o liečbe je podstatné, že účinok na albuminúriu a účinok na zlyhanie obličiek či kardiovaskulárne príhody vyžadujú odlišné dôkazy [1].

Čo sa porovnávalo

Korucu a spoluautori zahrnuli 32 randomizovaných štúdií s 21 678 účastníkmi s chronickou chorobou obličiek (CKD). V bayesovskom modeli hodnotili jednotlivé kombinácie liečiva a dávky samostatne. Pre hlavný ukazovateľ, pomer albumínu ku kreatinínu v moči (UACR), poskytlo údaje 16 štúdií s 9 149 účastníkmi. V porovnaní so štandardnou starostlivosťou všetky hodnotené dávky antagonistov mineralokortikoidových receptorov (MRA) znižovali UACR. Pomer priemerov oproti štandardnej starostlivosti bol 0,64 pri spironolaktóne 25 mg (95 % bayesovský interval vierohodnosti od 0,55 do 0,75) a 0,66 pri finerenóne 20 mg (od 0,60 do 0,72) [1].

Odhady sa vzťahujú na spoločný porovnávací režim. Na vyhlásenie klinickej rovnocennosti oboch liekov by bolo potrebné priame porovnanie s vopred určenou hranicou rovnocennosti a klinicky dôležitými výsledkami. Prenositeľnosť nepriamych odhadov obmedzujú rozdiely v populáciách, dĺžke sledovania a sprievodnej liečbe. Súhrnná zmena odhadovanej glomerulovej filtrácie (eGFR) od vstupu do konca sledovania navyše zachytávala v niektorých štúdiách prevažne skorú fázu liečby. Z takto meranej zmeny nemožno určiť, ako liek ovplyvní dlhodobé tempo poklesu eGFR [1].

Hyperkaliémia pri oboch liekoch

Odhadovaný absolútny nárast rizika hyperkaliémie oproti štandardnej starostlivosti bol 4,9 percentuálneho bodu pri spironolaktóne 25 mg (95 % bayesovský interval vierohodnosti od 3,1 do 6,6) a 5,3 percentuálneho bodu pri

finerenóne 20 mg (od 4,5 do 6,2). Metaanalýza neposkytla konzistentný dôkaz, že by jedna podtrieda MRA mala nižšie riziko pri všetkých dávkach. V metaregresii sa hyperkaliémia a ďalšie nežiaduce účinky vyskytovali častejšie v štúdiách s dlhším sledovaním a nižšou východiskovou eGFR. Dlhšie sledovanie dáva viac času na zachytenie udalostí. Výsledok na úrovni štúdií preto nepredpovedá riziko jednotlivca. Pri porovnaní treba zohľadniť aj vstupné hranice koncentrácie draslíka a spôsob jeho sledovania [1].

Klinické výsledky v randomizovaných štúdiách

Pri CKD s diabetom 2. typu má finerenón dôkazy z veľkých randomizovaných štúdií oproti placebu pri súbežnej blokáde systému renín-angiotenzín. Vo FIDELIO-DKD nastal primárny zložený výsledok, ktorý zahŕňal zlyhanie obličiek, pretrvávajúci pokles eGFR aspoň o 40 % alebo úmrtie z obličkovej príčiny, u 17,8 % pacientov pri finerenóne a u 21,1 % pri placebe (pomer hazardov 0,82, 95 % interval spoľahlivosti od 0,73 do 0,93). Vo FIGARO-DKD bol výskyt primárneho zloženého kardiovaskulárneho výsledku 12,4 % oproti 14,2 % (pomer hazardov 0,87, 95 % interval spoľahlivosti od 0,76 do 0,98). K rozdielu najviac prispelo menej hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie [2, 3].

Spironolaktón bol tiež predmetom randomizovanej štúdie s klinickými výsledkami. V BARACK-D pri CKD prevažne v štádiu G3b neprinieslo pridanie 25 mg spironolaktónu k bežnej starostlivosti preukázaný pokles výskytu primárneho zloženého výsledku úmrtia a kardiovaskulárnych udalostí (pomer hazardov 1,05, 95 % interval spoľahlivosti od 0,81 do 1,37). Liečbu v prvých šiestich mesiacoch prerušili približne dve tretiny pacientov priradených k spironolaktónu. Výsledok treba čítať s ohľadom na odlišnú populáciu, časté ukončenie liečby a absenciu priameho porovnania s finerenónom [4].

FIND-CKD rozšírila dôkazy na dospelých s albuminurickou CKD bez diabetu. Za 32 mesiacov finerenón spomalil priemerný ročný pokles eGFR oproti placebu o 0,7 ml/min/1,73 m² (95 % interval spoľahlivosti od 0,3 do 1,1). Zložený obličkový alebo kardiovaskulárny výsledok bol sekundárnym ukazovateľom (pomer hazardov 0,77, 95 % interval spoľahlivosti od 0,60 do 0,99). Samostatné obličkové a kardiovaskulárne odhady boli menej presné. Pri interpretácii treba odlíšiť výsledok štúdie od schválenej indikácie [5, 6].

Význam pre ambulantné rozhodovanie

Pri rozhodovaní o predpise má prednosť cieľ liečby. U pacienta s albuminurickou CKD a diabetom 2. typu by zámena finerenónu za spironolaktón na základe podobného poklesu UACR znamenala spoliehať sa na nepriamy dôkaz o náhradnom ukazovateli. Pri samostatnej indikácii spironolaktónu sa rozhoduje podľa tejto indikácie, funkcie obličiek, koncentrácie draslíka a možností sledovania. Podľa aktuálneho európskeho súhrnu charakteristických vlastností lieku je obličkovou indikáciou finerenónu albuminurická CKD spojená s diabetom 2. typu. Pred začatím liečby treba overiť koncentráciu draslíka a eGFR a po začatí alebo úprave dávky ich sledovať podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku [2, 3, 4, 6].

Literatúra

1. *Berfu Korucu, Ayse Colak, Reem Mustafa, Amy Earley, David C Wheeler. Dose-Specific Network Meta-Analysis of Mineralocorticoid Receptor Antagonists in CKD. Kidney Int Rep. 2026;11(12):107084.* DOI 10.1016/j.ekir.2026.107084 · PubMed 42965115 · Plný text
2. *George L Bakris, Rajiv Agarwal, Stefan D Anker, Bertram Pitt, Luis M Ruilope, Peter Rossing, Peter Kolkhof, Christina Nowack, Patrick Schloemer, Amer Joseph, Gerasimos Filippatos, FIDELIO-DKD Investigators. Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2020;383(23):2219-2229.* DOI 10.1056/NEJMoa2025845 · PubMed 33264825
3. *Bertram Pitt, Gerasimos Filippatos, Rajiv Agarwal, Stefan D Anker, George L Bakris, Peter Rossing, Amer Joseph, Peter Kolkhof, Christina Nowack, Patrick Schloemer, Luis M Ruilope, FIGARO-DKD Investigators. Cardiovascular Events with Finerenone in Kidney Disease and Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2021;385(24):2252-2263.* DOI 10.1056/NEJMoa2110956 · PubMed 34449181
4. *F D Richard Hobbs, Richard J McManus, Clare J Taylor, Nicholas R Jones, Joy K Rahman, Jane Wolstenholme, Sungwook Kim, Joseph Kwon, Louise Jones, Jennifer A Hirst, Ly-Mee Yu, Sam Mort, BARACK-D Investigators. Low-dose spironolactone and cardiovascular outcomes in moderate stage chronic kidney disease: a randomized controlled trial. Nat Med. 2024;30(12):3634-3645.* DOI 10.1038/s41591-024-03263-5 · PubMed 39349629

5. *Hiddo J L Heerspink, Brendon L Neuen, Rajiv Agarwal, David Z I Cherney, Carolyn S P Lam, Katherine R Tuttle, Christoph Wanner, Pantelis Sarafidis, Niels Jongs, J David Smeijer, Meike Brinker, Nicole Rethemeier, Patrick Schloemer, Paula Vesterinen, David Goldsbury, Sara Dizayee, Jon W Mares, Vlado Perkovic, FIND-CKD Investigators. Finerenone in Persons with Chronic Kidney Disease without Diabetes. N Engl J Med. 2026;395(6):533-545. DOI 10.1056/NEJMoa2604625 · PubMed 42246672*
6. *Európska lieková agentúra. Kerendia. Súhrn charakteristických vlastností lieku, časti 4.1, 4.2 a 5.1. Dokument EMA*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=spironolakton-finerenon-ckd-sietova-metaanalyza · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.